



Praxis für Orthopädie und Unfallchirurgie Kempten

Dr. med. Tobias Fillep
Antonie Hartmann
Dr. Dr. med. Wolfgang Maletius

Orthopädie und Unfallchirurgie
Spezielle Unfallchirurgie
Durchgangsarzt der BG
Manuelle Medizin/Chirotherapie
Sportmedizin
Akupunktur

Grabengasse 2
87435 Kempten

Tel.: 0831 29908
Fax: 0831 10639

praxis@ortho-unfall-kempten.de
www.ortho-unfall-kempten.de

An den weiterbehandelnden Arzt

Kempten, 05.08.2026

WM-FS

Wir berichten über folgenden Patienten

Thomas Stadelmann
geb.am 06.04.1994
wohnhaft in 87448 Waltenhofen, Plabennecstr. 39

Aktuelle Anamnese

05.08.2026 — Es liegt eine jahrelange Anamnese von Vorfußschmerzen links vor, 2020 war er deswegen auch bei meinem Vorgänger in Behandlung ist dann zu Fuß Orthopäden/Chirurgen nach München gewechselt. Dort wurde 2022 eine Osteotomie am Grundgelenk der 2. Zehe durchgeführt bei der sich zuvor eine hartnäckige Synovialitis und Arthritis gezeigt hatte. Seit einem 3/4 Jahr Beschwerden nun am Grundgelenk der 4. Zehe im linken Fuß. Sportlich ist Herr Stadelmann maximal aktiv zum Teil mit täglichem/wöchentlichen Marathonläufen/Ultramarathon, darunter Kilometer Fahrradfahren und intensiven bouldern. Beruflich sitzende Tätigkeit als Programmierer. Im Alltag hat er auch keine Beschwerden. Bei einer rheumatologischen Untersuchung 2022 war jedoch bis auf den positiven HLAB-27 kein weiterer auffälliger Wert gefunden worden, er beschreibt noch parallel zu den Schmerzen am Zehengrundgelenk einen Schmerz am linken ISG. Ibuprofen würde ihm sehr gut helfen (etwa 16 Stunden). Nach der Operation war er direkt beschwerdefrei. Einlagen haben ihm keine Besserung erbracht.

Ein aktuelles MRT liegt uns vor.

Im mitgeführten MRT des linken Vorfuß vom 18.02.2026 zeigt sich am MTP 4 Gelenk ein Erguss mit Synovialitis, diffuse Aktivierung der Gelenkkapsel und der umgebenen Weichteile sowie Peritendinitis an den Beugeschneen. Begleitend mäßige Aktivierung der beteiligten Knochen. Befund DD vereinbar mit einer Psoriasis-Arthritis.

Aktueller Befund

05.08.2026 Knick-Senk-Spreizfuß bds, minimal varische Beinachse, Beckengeradstand, diffuse Schmerzangabe über dem linken ISG. Keine Schmerzausstrahlung oder Taubheitsgefühl in den unteren Extremitäten.
Becken/Schultergradstand, Wirbelsäule im Lot, leicht varische Beinachse, mäßig ausgeprägter Knick-Senk-Spreizfuß. Die LWS heute frei beweglich, keine eindeutige Druckdolenz am ISG links. FBA 20 cm. Am linken Fuß lokale deutliche Druckdolenz über dem Grundgelenk der 4. Zehe bei ansonsten freier Sprunggelenks und Zehengelenksbeweglichkeit keine Druckdolenz metatarsal, keine vermehrte metatarsale Verschwielung.

Röntgen

05.08.2026 Aufgrund d. Aktualität d. vorliegenden MRT & Röntgen-Aufnahmen wurde heute auf die erneute Anfertigung von Röntgenaufnahmen zum Schutz d. Pat. verzichtet.

Sono

05.08.2026 Linker Fuß: leichter Reizzustand im Bereich des MTP 4. Der rechte Fuß zum Seitenvergleich.

Aktuelle Diagnose

05.08.2026 ISG-Symptomatik links {M54.17}
Isolierte Arthritis MTP 4-Gelenk linker Fuß {M25.5-}
V. a. Rheumatoide Arthritis V. a. Psoriasis Arthritis (HLAB-27 positiv) {M06.99}

Dauer Diagnose

05.08.2026 Knick-Senk Spreizfuß bds {Q66.8}

Therapie

05.08.2026 Untersuchung. Beratung. Die Ursache der Beschwerden kann nicht an einer mechanischen Fehlstellung oder der hohen sportlichen Belastung liegen. Aus meiner Sicht muss eine generalisierte Ursache z. B. die bereits vermutete Psoriasisarthritis vorliegen. Er wird sich bei Dr. Rossmanith noch vorstellen, sollte hier ein unauffälliger Befund auftreten müsste man noch einmal über weitere Störfelder reden, er meldet sich definitiv noch einmal bei mir.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Dr. med. Wolfgang Maletius

(Dieser Brief wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.)

Stadelmann Thomas geb. am 06.04.1994